EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79830
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-01 08:09:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALVARO ANDRES FLORES GUERRERO			RUN	: 16.845.587-9
F.Nac	: 24-11-1988	Edad	: 35 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: SAN GREGORIO			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-24	Fecha Egreso	: 2024-03-01 08:09:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Neumonia basal dereche en vias de resolucion
2) Discapacidad intelectual
3) Hipotiroidismo
4) Asma
5) Epilepsia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta el 23/02 por cuadro de 24 hrs de evolucion de CEG, sensacion febril, sumado a episodio de convulsion tonico clonica generalizada. Destaca antec de hospitalizacion previa por HDA. Examenes de lab al ingreso destaca PCR 500 Gb 15,7.TAC de torax se describe con foco de consolidacion en base derecha Se ingresa con Dg de Neumonia basal derecha para terapia ATB.
Durante estancia evoluciona favorablemente, con disminucion progresiva de los parametros inflamatorios, con mejoria progresiva de tolerancia a VO.

Paciente HDN estable, familiar refiere que paso buena noche, con mejor tolerancia a VO en comparativa a dias anteriores, sin peak febril, sin requerimientos de O2 suplementario, diuresis y deposiciones (+)
Ex de lab -> crea 0,5; PCR 72,9; uremia 9; Na/K/Cl 138/4.5/102; Gb 8,4; Hb/Hcto 10.4/31.2; plaq 291000; segment 51%; , HC 1 y 2 negativos
Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 6 hospitalizado, dia N° 6 de tratamiento ATB con tazonam, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso/respiratorio: HC negativos, sumado a parametros inflamatorios a la baja, se procedera a desescalar terapia ATB, se continuara hospitalizacion via HODOm, examenes de control 5/03
4) ORL, se procedera a evaluacion ambulatoria por ORL para estudio de Tr deglutorio

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano a tolerancia
3. O2 suplemnetario para sat > 93%
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 7 dias
5. Clexane 40 mg al dia SC por 7 dias
6. Carbamazepina 200 mg, 2 comp c/8hrs VO
7. Acido Valproico 500 mg, 2 comp c/8hrs VO
8. Levetiracetam 500 mg, 3 comp c/12 hrs VO
9. Omeprazol 20 mg al dia VO por 7 dias
10. Fluticasona/salmeterol2 puff c/12 hrs por AC
11. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6 hrs por AC
12. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 7 dias
13. KNT respiratorio y motora una vez al dia
14. Cuidados de enfermeria prevencion UPP
15. Examenes de control 05/03
16. CSV c/8hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO